

서울대학교병원마인드바디센터The SHIM

기억 다루기 프로그램

매뉴얼

소개의 글

기억 다루기 프로그램은 트라우마 증상을 보이는 환자로 하여금 트라우마 기억을 다루는 기술을 습득하도록 돕고자 제작된 프로그램으로, Marx 등에 의해 개발된 쓰기 노출 치료(written exposure therapy, WET) 지침에 기반하여 제작되었습니다.

기억 다루기 프로그램 매뉴얼은 정신건강 전문가가 프로그램의 내용을 쉽게 배우고 적용할 수 있도록 구체적인 지시 내용과 참고자료를 포함하고 있습니다. 이 매뉴얼은 서울대학교병원 정신건강의학과와 기부금 사업을 통해 설립된 비약물적 치료센터 더심(The Shim) 프로젝트의 일환으로 서울대학교병원 정신건강의학과 불안/공황/공포클리닉에서 개발하였으며, 향후 정신건강 전문가의 자문과 연구 결과를 반영하여 수정 및 보완될 예정입니다. 기억 다루기 프로그램의 실시와 관련하여 문의사항이 있다면 서울대학교병원 정신건강의학과 불안/공황/공포클리닉(snuh.np.theshim@gmail.com)으로 문의해주시기 바랍니다.

2022 년 11 월
서울대학교병원 정신건강의학과 부교수 최수희

기억 다루기 프로그램 매뉴얼 목차

소개의 글	2
기억 다루기 프로그램 매뉴얼 활용 가이드	4
Part 1. 트라우마의 세부사항: 1 차 쓰기치료	7
Part 2. 트라우마의 세부사항: 2 차 쓰기치료	11
Part 3. 트라우마의 영향: 3 차 쓰기치료	14
Part 4. 트라우마의 영향: 4 차 쓰기치료	17
Part 5. 트라우마의 영향: 5 차 쓰기치료	20
부록	22
참고문헌	24

1. 기억 다루기 프로그램이란?

기억 다루기 프로그램은 트라우마 경험자 중 트라우마 기억을 다루는 데에서 어려움을 경험하는 대상자들을 위하여 트라우마 기억 및 관련 자극에 노출하는 것을 목적으로 합니다. 특히 본 프로그램에서는 높은 치료효과에 더하여 지속성과 접근성을 고려한 글쓰기 처치를 활용하고자 합니다. 트라우마 경험을 글로 작성하면서 기억이 위협적이지 않다는 것을 학습하는 것을 목적으로 하며, 트라우마 경험의 긍정적인 부분을 재평가하고 숙고하도록 도우면서 외상후 성장을 촉진할 수 있도록 돕습니다(Calhoun & Tedeschi, 2012). 이 프로그램은 Marx 등에 의해 개발된 쓰기 노출 치료(written exposure therapy, WET)에 기반하여 제작되었고, 쓰기 지침을 바탕으로 트라우마의 세부 사항과 영향에 대하여 자유롭게 작성한 후 확인 면담을 진행하는 과정으로 이루어져 있습니다. 본 프로그램은 구체적인 지시와 참고자료를 바탕으로 하여 구조화된 방식으로 활용할 수 있도록 제작되었고, 향후 정신건강 전문가의 자문과 연구 결과를 반영하여 추가적으로 수정 및 보완될 예정입니다.

2. 기억 다루기 프로그램의 개발 목적 및 목표

트라우마를 다루기 위한 대표적인 치료에는 지속적 노출치료(prolonged exposure, PE), 외상-초점 인지행동치료(trauma-focused cognitive therapy, TF-CBT) 등이 있으며, 대부분 트라우마 사건에 대한 노출에 기반을 두고 있습니다. 노출 기반 치료에서는 트라우마와 관련된 자극에 개인을 반복적으로 노출시키면서 공포에 대한 내성을 습득하고 새로운 맥락에서 안전감을 학습할 수 있도록 돕습니다. 반복적인 노출과 안전감 획득 경험을 통해 환자는 외상 사건에 대하여 과잉일반화 등의 인지적 왜곡을 수정하고 보다 정확하게 사건을 평가할 수 있게 됩니다(Abramowitz et al., 2019). 그러나 기존의 노출 기반 치료는 높은 치료 효과에도 불구하고 높은 탈락률과 경제적, 시간적 면에서 낮은 접근성, 높은 훈련 수준 요구량으로 다수의 환자에게 적용하기에 현실적 어려움이 있는 실정입니다(Sloan et al., 2013). 따라서 본 프로그램은 치료적 노출 시 보다 안전하고 부담이 적은 방식의 치료를 제공하는 것을 목표로 하여 글쓰기를 통한 기억 노출에 방점을 두어 제작되었습니다.

본 프로그램의 목표는 다음과 같습니다.

- 대상자로 하여금 스트레스 기억을 글로 작성하도록 하면서 트라우마 기억이 위협적이지 않다는 것을 학습하도록 돕습니다.
- 대상자가 트라우마 경험의 긍정적인 부분을 재평가하고 숙고하도록 돕습니다.

3. 기억 다루기 프로그램의 구성 내용

기억 다루기 프로그램은 트라우마 기억 및 관련 자극에 대한 노출을 목표로 하는 프로그램으로 다음의 5 회기로 구성되어 있으며, 개인 치료 세팅에서 활용하도록 제작되었습니다.

회기	회기명	내용
1	트라우마의 세부사항 : 1 차 쓰기치료	- 트라우마와 관련하여 내가 경험하고 있는 반응을 탐색한다. - 트라우마 사건의 구체적인 세부사항에 대하여 기록한다,
2	트라우마의 세부사항 : 2 차 쓰기치료	- 트라우마 사건의 구체적인 세부사항에 대하여 기록한다, - 트라우마 기억에 온전히 자신을 노출한다.
3	트라우마의 영향 : 3 차 쓰기치료	- 트라우마 사건이 나에게 미친 영향에 대하여 기록한다, - 트라우마 기억을 처리하는 과정에 관여한다.
4	트라우마의 영향 : 4 차 쓰기치료	- 트라우마 사건이 나에게 미친 영향에 대하여 기록한다, - 트라우마 관련 자극에 대한 왜곡된 인지를 수정하고 사건을 정확하게 평가한다.
5	트라우마의 영향 : 5 차 쓰기치료	- 트라우마 사건이 나에게 미치는 영향과 의미에 대하여 기록한다, - 트라우마로부터 새로운 의미를 발견한다.

4. 기억 다루기 프로그램의 실시자

본 프로그램은 다음의 자격을 갖춘 자에 의한 실시가 권장됩니다.

- ✓ 정신건강의학과 전공의 이상
- ✓ 정신건강전문요원(간호사, 사회복지사, 임상심리사) 2 급 이상
- ✓ 정신건강전문요원 2 급 이상에 준하는 자격증을 가진 자

다음과 같은 자세와 마음가짐으로 실시하는 것을 권장합니다.

- ✓ 고통스러운 기억에 직면하기 위하여 용기를 낸 대상자에 대하여 아낌없는 지지와 격려를 바탕으로 치료적 관계를 형성합니다.
- ✓ 대상자가 기존에 보유하고 있는 강점을 발굴하여 내적 자원을 강화할 수 있도록 돕습니다.
- ✓ 대상자를 특정 질환 환자로 범주화하기보다는 각각의 개별적 특성을 가진 존재로서 있는 그대로 바라보고 존중하며 판단하지 않습니다.

5. 프로그램 참여가 권장되지 않는 경우

다음의 경우에 해당하는 대상자는 프로그램 참여가 권장되지 않습니다.

- ✓ 지지체계가 불충분한 경우
- ✓ 치료를 통해 직장, 학업적 지장이 중대할 것으로 예상되는 경우
- ✓ 자살사고, 해리, PTSD 증상의 일시적 악화를 감내할 수 없다고 판단되는 경우

- ✓ 사건에 대한 기억이 없거나 일부 빈약한 세부 사항만 있는 트라우마
- ✓ 가정 폭력과 같이 계속 진행중인 트라우마의 위험이 있는 경우
- ✓ 트라우마 기억에 직면하는 것에 강한 거리낌을 표현하는 경우
- ✓ 환자가 치료자의 주 언어로 글을 쓸 수 없는 경우
- ✓ PTSD 가 주 진단이 아닌 경우
- ✓ 심각한 물질 사용 장애나 활성화된 정신증적 증상이 있는 경우
- ✓ 자타해 위험 상태에 있는 경우
- ✓ 해리 증상이 PTSD 증상보다 더 심하고 간섭을 유발하는 경우

PART 1. 트라우마의 세부사항

: 1 차 쓰기치료

준비물	워크북, 필기구(개별 지참)
목표	트라우마와 관련하여 내가 경험하고 있는 반응을 탐색한다. 트라우마 사건의 구체적인 세부사항에 대하여 기록한다,
회기 개요	1. 나의 트라우마 알아보기 (10 분) 2. 트라우마 심리교육 (10 분) 3. 쓰기노출치료 심리교육 (10 분) 4. 1 차 쓰기노출치료 (30 분) 5. 확인면담 (20 분)

1. 나의 트라우마 알아보기	① 프로그램 소개 & 서약서 작성(워크북 2~3p) - “안녕하세요, 쓰기노출치료의 첫 회기입니다. 이 시간에 우리는 트라우마 증상과 쓰기노출치료의 기본 원리에 대해 알아보는 시간을 가질 것입니다.” - 서약서를 읽으며 프로그램의 목적과 참여 태도에 대하여 숙지한 후 서명하도록 한다. - 프로그램의 과정을 보며 각 회기별 활동을 소개하고 프로그램 일정 및 시간을 공지한다. ② 척도 소개(워크북 4~6p) 현재 경험하고 있는 불편감 점수를 0~100 점 범위에서 기입한 후 우울, 불안 수준에 대해서도 평정하도록 하고, 앞으로의 프로그램에서 매 회기 이 척도를 실시할 예정임을 알려준다. ③ 대표 트라우마 파악하기(워크북 7~8p) - “가장 먼저 우리가 앞으로 5 회기 동안 글쓰기를 할 나의 대표 트라우마(index trauma)를 파악하는 시간을 가져볼 것인데요, 우선 트라우마가 어떤 것인지, 나의 트라우마는 어떤 것이 있는지 표시하고 간략하게 이야기해보도록 하겠습니다.” - 증상 및 병력과 관련하여 내담자가 추가로 이야기하고 싶어 할 수 있는데, 이에 대해 기나긴 토론에 빠지지 않도록 주의하면서 간결하게만 파악한다. - 단일 트라우마 사건을 경험한 환자의 경우 점검해야 하는 사항은 다음과 같다. 환자의 트라우마 사건에 대해 상세하게 파악할 필요는 없으며, 환자가 명확히 말로 꺼내기 어려워한다면 ‘그 사건의 시작과 끝은 무엇입니까?’(e.g., 교통사고라면 불빛이 번쩍 하는 것[시작]~정신차렸을 때 119가 수습하고 있는 것[끝])→’이 10 분 사이에 있었던 일들을 30 분 동안 아주 자세하게 기록해보도록 합시다’와 같이 구체화한다. - 현재 증상의 발생과 관련 있는 트라우마 사건인가?
-----------------	---

	- PTSD criteria A 에 해당하는가? - 트라우마 사건의 처음과 끝이 어디인가? 어디에서부터 어디까지 쓸 것인가? 환자가 얼마나 상세하게 기억하고 있는가? - 복합 트라우마를 가지고 있는 환자의 경우, 다음의 기준을 바탕으로 선택하고, ‘이 한 가지의 사건에 대해 작성하는 과정에서 그 아래의 트라우마에 대한 처리도 일어날 수 있다’고 안심시킨다. - 특히 기억이 명확한 사건 - 현재 증상의 형성과 가장 연관성이 높은 한 사건 - 지금 악몽이나 침습, 회피와 관련되어 두드러지는 한 사건 - 트라우마에 대해 생각하는 과정에서 치료목표를 설정하고 넘어간다. - “이번에는 쓰기노출치료를 통해 우리가 가져가야 할 목표에 대해 논의해 보겠습니다. 세 가지 질문에 대해 생각해볼 것인데요, 세 번 모두 같은 대답을 하셔도 됩니다. 중요한 지점이기 때문에 세 번 여쭙보는 것입니다.”
2. 트라우마 심리교육	① 트라우마 경험 후 생길 수 있는 변화(워크북 9p) - 워크북의 내용을 읽으면서 환자의 증상에 대해 생각해보도록 한다. 모듈 1 에서 같은 내용을 한번 다루었으므로 모듈 1 에 참여한 참가자에 대해서는 간단하게 되짚는 정도로 교육하고 넘어간다. - 환자가 경험하는 증상이 트라우마를 경험한 개인들은 누구나 경험할 수 있는 것임을 타당화하고, 대부분의 증상들은 자연회복의 경과를 거치지만 장기간 회복되지 않는 경우 PTSD 진단을 내리기도 하고, 이 치료는 이러한 증상의 자연회복을 빠르게 할 수 있도록 돕는 역할을 한다는 점을 알려준다. ② 트라우마 경험 후 생길 수 있는 변화(워크북 10p) - 워크북의 내용을 읽으면서 환자의 특성에 대해 생각해보도록 한다. 모듈 1 에서 같은 내용을 한번 다루었으므로 모듈 1 에 참여한 참가자에 대해서는 간단하게 되짚는 정도로 교육하고 넘어간다.
3. 쓰기치료 심리교육	① 쓰기노출치료의 필요성(워크북 11p) - 쓰기노출치료에 대하여 소개한다. - “앞서 살펴본 바와 같이, 트라우마 기억이나 관련 자극으로부터 회피하는 행동은 단기적으로 어느 정도 안정감을 줄 수 있지만, 장기적으로는 사태를 악화시킬 수 있습니다. 계속해서 피한다면 자신의 두려움을 극복할 기회를 놓치게 되고, 결과적으로 나의 삶의 범위는 자꾸만 줄어들게 됩니다. 따라서 우리는 트라우마 기억으로부터 도피하는 이전의 노력으로부터 과감하게 벗어나 트라우마 기억에 오히려 접근하고 나를 노출시키는 방법으로 이러한 문제를 해결하려고 합니다.” - “만화를 보고 함께 이야기해 봅시다. 나의 트라우마 경험을 글로 써본 적이 있나요? 트라우마 기억은 우리의 일상과 너무나 크게 동떨어진 충격적인 사건이기 때문에 우리가 일반적으로 갖고 있는 기억들과는 조금 다른 형태로 우리의 마음에 저장됩니다. 여기 이 퍼즐과 같이 군데군데 삭제되고 비어 있는 경우가 많고, 이 중 일부분만 뚜렷하게 강조된 채로 우리 마음에 남아

	있습니다. 그리고 이 조각들은 일반적인 기억들처럼 우리가 원할 때 꺼낼 수 있게 잘 정리되어 있는 것이 아니라, 우리가 원치 않는 순간에도 뒤죽박죽인 채 불쑥불쑥 튀어나옵니다. 그러다보니 우리의 좋은 기억들마저 이 트라우마 기억에 다 덮여 버리고 말지요. 우리는 이 기억들이 다른 기억들과 마찬가지로 잘 정돈되고, 내가 필요할 때만 꺼낼 수 있는 형태로 저장되기를 바랍니다. 글쓰기를 하는 과정은 이러한 기억의 처리를 도와준다고 알려져 있고, PTSD 환자분들을 위한 치료에서 이 쓰기노출치료가 효과가 있다는 것이 반복적으로 확인되고 있습니다.” ② 쓰기노출치료 소개(워크북 12p) - “구체적으로 글쓰기를 통한 노출이 어떻게 증상 완화를 도와줄 수 있는지 한번 쓰기노출치료에 대한 설명을 같이 읽어 볼까요?” - 워크북에 적힌 소개 및 지침을 그대로 읽고, 습관화 그래프를 바탕으로 반복적인 노출이 주는 이점에 대해 소개한다. - “기억에 노출하는 과정에서 우리의 심리적 고통감과 증상은 이 그래프와 같이 변화합니다. 처음에는 비교적 오래 강한 고통감을 느낄 수 있지만, 시간이 지나면 이러한 증상은 반드시 가라앉습니다. 그리고 두 번째, 세 번째로 같은 기억을 반복적으로 떠올리게 되면 점점 더 익숙해지게 되지요. 처음 심리적 고통을 경험할 때 우리는 마치 이 고통이 끝도 없이 치솟은 채로 계속 유지될 것처럼 느끼지만, 실상은 이처럼 점차 익숙해지고, 습관화되게 됩니다.”
4. 1 차 쓰기치료	1 차 쓰기노출치료 실시(워크북 13~14p) - 쓰기노출을 위한 준비사항 - 빈 방에서 환자 혼자 글쓰기를 실시하도록 하고, 위급사항이 있을 경우 방 안의 벨을 눌러 치료자에게 알리도록 한다. - 치료자는 환자의 쓰기에 관여하지 않고 심한 해리, 공황이 올 때 안정화를 돕는 정도로는 관여할 수 있다. - 한 회기에서는 30 분의 글쓰기 시간이 필요하며, 글을 다 쓴 후에도 시간이 남는다면 처음부터 반복해서 다시 쓰도록 한다. - 글쓰기 종료 후에는 15~20 분 가량의 확인면담(check-in interview)을 실시한다.
5. 확인면담	① 확인면담 - 내담자의 불편감 점수를 확인한다. 프로그램을 시작할 때 내담자가 보고한 불편감 점수와 어떤 차이가 있는지 확인한다. 이 변화와 연관지어 프로그램에 대한 피드백을 받고, 긍정적인 점수 변화가 있었다면 격려하며 치료동기를 강화한다. - 초반 회기에서의 정상적인 반응으로 SUDS 가 상당히 높을 수 있다. SUDS 가 높아 불안해하는 환자를 안심시킨다. - “아직 트라우마 기억에 대한 충분한 습관화가 이루어지지 않았을 뿐입니다. 힘드시겠지만 반복적으로 노출하는 과정에서 이 고통감은 낮아질 것입니다.” - 다음의 확인면담을 통해 쓰기 경험에 대해 대화를 나눈다. - 구체적인 트라우마 기억에 대한 이야기는 하지 않으며, 글쓰기 경험 자체에 대하여 이야기한다. 단, 치료자가 글을 훑어본 후 인지 재구조화에 도움이 될 수 있을 것으로 판단되는 내용이 있다면 다루어보아도 좋다.

	- 환자의 고통이 지나치다고 판단되는 경우 우선적으로 안정화를 통해 덜 고통스러운 상태로 돌아갈 수 있도록 한다. - 환자가 고통스러운 기억을 스스로 직면할 수 있는 능력과 용기가 있다는 것을 인식하고 이에 대한 긍정적인 피드백을 준다 - 필요할 때 지원을 하고 차분함을 유지하도록 돕는다. - 외상경험을 떠올리는 것에 대한 환자의 생각과 감정을 표출할 수 있도록 한다. - 외상사건 동안 그리고 이후의 환자의 반응과 행동을 중성화하고 이를 스스로 이해할 수 있도록 돕는다. - 회기 중 혹은 회기와 회기 사이에 관찰된 습관화에 대해 말해준다. - 환자의 감정반응 중 특별히 중요하거나 의미 있다고 생각되는 부분에 대해 질문한다. - 치료가 진행되는 동안 환자의 PTSD 증상을 지속시키는 도움되지 않는 부정적 사고 또는 신념이 발견되면 확인면담 과정에서 그러한 사고와 신념을 중점에 두고 논의한다. - 개방형 질문을 사용하여 환자의 생각을 촉진시킨다. 환자가 외상을 어떻게 바라보고 어떻게 느껴야 하는지 직접적으로 말하지 않도록 한다. - 부록의 PETQ와 같은 설문지를 활용할 수 있다. ② 마무리 - “쓰기노출치료를 실시하기 위한 첫 회기를 잘 마쳐주셨습니다. 앞으로 치료의 과정이 쉽지만은 않겠지만, 이 치료를 시작한 우리의 처음 마음을 기억하면서 잘 버텨보도록 하겠습니다. 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다.”
--	--

PART 2. 트라우마의 세부사항

: 2 차 쓰기노출치료

준비물	워크북, 필기구(개별 지참)
목표	트라우마 사건의 구체적인 세부사항에 대하여 기록한다, 트라우마 기억에 온전히 자신을 노출한다.
회기 개요	0. 들어가며 (5 분) 1. 2 차 쓰기노출치료 (30 분) 2. 확인면담 (20 분)

0. 들어가며	① 회기와 회기 사이에 점검해야 할 것 - 다음 회기 전까지 치료자는 환자가 쓴 내용을 읽어 보면서 쓰기 지침을 잘 따랐는지, 쓰기에 잘 집중했는지, 분량은 적절한지에 대해 확인한다. 쓰기 과정에서 회피를 하면서 트라우마 사건이 발생하기 직전까지만 쓰는 등 트라우마 사건을 구체적으로 적지 못하는 경우가 있다. 이것은 제대로 된 노출이 아니기 때문에 다음 회기 때 환자에게 피드백을 주어서 본격적인 사건에 대해 써보자고 권유할 수 있다. 혹은 사건에 대한 나열만 있고 감정은 없는 경우가 있는데, 이럴 경우에는 감정에 대해 조금 더 써보자고 이야기해볼 수 있다. 환자가 과거 경험에서 느낀 감정이 아닌 지금 현재의 감정에 대해서만 서술하고 있다면 ‘지금 현재의 분노가 아니라 그때 트라우마 당시에 내가 구체적으로 무엇을 생각하고 느꼈는지에 대해 쓰는 것이다’ 식으로 재구조화해줄 필요가 있다. 치료에서의 회피 패턴이 이후로도 계속되면 WET 를 지속할 수 있을지에 대해서 고려해보아야 한다. ② 한 주간의 근황 - “안녕하세요, 한 주간 어떻게 지내셨나요? 트라우마 기억을 다루는 과정에서 힘들었던 기억이 다시 되살아나면서 어려움이 있었을 수도 있는데, 어떠셨는지 궁금합니다.” - 환자가 어려웠던 점에 대해 이야기한다면 ‘그럼에도 불구하고 이 치료를 다시 찾아주신 것이 정말 대단한 결정이라고 생각된다’ 등의 방식으로 격려와 지지를 아끼지 않는다. - 프로그램 시작 전에 현재 SUDS 를 작성하도록 한다.
1. 2 차 쓰기치료	2 차 쓰기노출치료 실시(워크북 15~16p) - 워크북에 적힌 글을 환자와 소리내어 읽으며 쓰기의 내용과 과정을 점검한다. - 쓰기노출을 위한 준비사항 - 빈 방에서 환자 혼자 글쓰기를 실시하도록 하고, 위급사항이 있을 경우 방 안의 벨을 눌러 치료자에게 알리도록 한다. - 치료자는 환자의 쓰기에 관여하지 않고 심한 해리, 공황이 올 때 안정화를 돕는 정도로는 관여할 수 있다.

		- 한 회기에서는 30 분의 글쓰기 시간이 필요하며, 글을 다 쓴 후에도 시간이 남는다면 처음부터 반복해서 다시 쓰도록 한다. - 글쓰기 종료 후에는 15~20 분 가량의 확인면담(check-in interview)을 실시한다.
2. 확인면담	① 확인면담 - 내담자의 불편감 점수를 확인한다. 프로그램을 시작할 때 내담자가 보고한 불편감 점수와 어떤 차이가 있는지 확인한다. 이 변화와 연관지어 프로그램에 대한 피드백을 받고, 긍정적인 점수 변화가 있었다면 격려하며 치료동기를 강화한다. - 초반 회기에서의 정상적인 반응으로 SUDS 가 상당히 높을 수 있다. SUDS 가 높아 불안해하는 환자를 안심시킨다. - “아직 트라우마 기억에 대한 충분한 습관화가 이루어지지 않았을 뿐입니다. 힘드시겠지만 반복적으로 노출하는 과정에서 이 고통감은 낮아질 것입니다.” - 다음의 확인면담을 통해 쓰기 경험에 대해 대화를 나눈다. - 구체적인 트라우마 기억에 대한 이야기는 하지 않으며, 글쓰기 경험 자체에 대하여 이야기한다. 단, 치료자가 글을 훑어본 후 인지 재구조화에 도움이 될 수 있을 것으로 판단되는 내용이 있다면 다루어보아도 좋다. - 환자의 고통이 지나치다고 판단되는 경우 우선적으로 안정화를 통해 덜 고통스러운 상태로 돌아갈 수 있도록 한다. - 환자가 고통스러운 기억을 스스로 직면할 수 있는 능력과 용기가 있다는 것을 인식하고 이에 대한 긍정적인 피드백을 준다 - 필요할 때 지원을 하고 차분함을 유지하도록 돕는다. - 외상경험을 떠올리는 것에 대한 환자의 생각과 감정을 표출할 수 있도록 한다. - 외상사건 동안 그리고 이후의 환자의 반응과 행동을 중성화하고 이를 스스로 이해할 수 있도록 돕는다. - 회기 중 혹은 회기와 회기 사이에 관찰된 습관화에 대해 말해준다. - 환자의 감정반응 중 특별히 중요하거나 의미 있다고 생각되는 부분에 대해 질문한다. - 치료가 진행되는 동안 환자의 PTSD 증상을 지속시키는 도움되지 않는 부정적 사고 또는 신념이 발견되면 확인면담 과정에서 그러한 사고와 신념을 중점에 두고 논의한다. - 개방형 질문을 사용하여 환자의 생각을 촉진시킨다. 환자가 외상을 어떻게 바라보고 어떻게 느껴야 하는지 직접적으로 말하지 않도록 한다. - 부록의 PETQ 와 같은 설문지를 활용할 수 있다. ② 마무리 - “수고하셨습니다. 귀가한 후로 트라우마 기억이 다시 떠오르면서 굉장히 힘드실 수 있고, 이로 인해 일시적으로는 증상이 악화되는 것처럼 느낄 수 있지만, 이는 실제로는 내면이 트라우마를 덜 회피하고 있다는 것을 의미하기 때문에 치료가 효과가 있다는 신호로 볼 수 있습니다. 마치 오랫동안 운동을 하지 않다가 갑자기 운동을 하고 나면 처음에 많이 아픈 것과 같습니다. 그러나 이 통증을 이겨내고 규칙적으로 운동을 계속하면 통증이 사라지고	

	근육이 강화되기 시작할 것입니다. 이제 이 치료의 진정한 이점을 얻을 수 있도록 이러한 증상을 극복해야 할 때입니다.”
--	--

PART 3. 트라우마의 영향

: 3 차 쓰기노출치료

준비물	워크북, 필기구(개별 지참)
목표	트라우마 사건이 나에게 미친 영향에 대하여 기록한다, 트라우마 기억을 처리하는 과정에 관여한다.
회기 개요	0. 들어가며 (5 분) 1. 3 차 쓰기노출치료 (30 분) 2. 확인면담 (20 분)

0. 들어가며	① 회기와 회기 사이에 점검해야 할 것 - 다음 회기 전까지 치료자는 환자가 쓴 내용을 읽어 보면서 쓰기 지침을 잘 따랐는지, 쓰기에 잘 집중했는지, 분량은 적절한지에 대해 확인한다. 쓰기 과정에서 회피를 하면서 트라우마 사건이 발생하기 직전까지만 쓰는 등 트라우마 사건을 구체적으로 적지 못하는 경우가 있다. 이것은 제대로 된 노출이 아니기 때문에 다음 회기 때 환자에게 피드백을 주어서 본격적인 사건에 대해 써보자고 권유할 수 있다. 혹은 사건에 대한 나열만 있고 감정은 없는 경우가 있는데, 이럴 경우에는 감정에 대해 조금 더 써보자고 이야기해볼 수 있다. 환자가 과거 경험에서 느낀 감정이 아닌 지금 현재의 감정에 대해서만 서술하고 있다면 ‘지금 현재의 분노가 아니라 그때 트라우마 당시에 내가 구체적으로 무엇을 생각하고 느꼈는지에 대해 쓰는 것이다’ 식으로 재구조화해줄 필요가 있다. 치료에서의 회피 패턴이 이후로도 계속되면 WET 를 지속할 수 있을지에 대해서 고려해보아야 한다. ② 한 주간의 근황 - “안녕하세요, 한 주간 어떻게 지내셨나요? 트라우마 기억을 다루는 과정에서 힘들었던 기억이 다시 되살아나면서 어려움이 있었을 수도 있는데, 어떠셨는지 궁금합니다.” - 환자가 어려웠던 점에 대해 이야기한다면 ‘그럼에도 불구하고 이 치료를 다시 찾아주신 것이 정말 대단한 결정이라고 생각된다’ 등의 방식으로 격려와 지지를 아끼지 않는다. - 프로그램 시작 전에 현재 SUDS 를 작성하도록 한다.
1. 3 차 쓰기치료	3 차 쓰기노출치료 실시(워크북 19~20p) - 워크북에 적힌 글을 환자와 소리내어 읽으며 쓰기의 내용과 과정을 점검한다. - 쓰기노출을 위한 준비사항 - 빈 방에서 환자 혼자 글쓰기를 실시하도록 하고, 위급사항이 있을 경우 방 안의 벨을 눌러 치료자에게 알리도록 한다. - 치료자는 환자의 쓰기에 관여하지 않고 심한 해리, 공황이 올 때 안정화를 돕는 정도로는 관여할 수 있다.

	- 한 회기에서는 30 분의 글쓰기 시간이 필요하며, 글을 다 쓴 후에도 시간이 남는다면 처음부터 반복해서 다시 쓰도록 한다. - 글쓰기 종료 후에는 15~20 분 가량의 확인면담(check-in interview)을 실시한다.
2. 확인면담	① 확인면담 - 내담자의 불편감 점수를 확인한다. 프로그램을 시작할 때 내담자가 보고한 불편감 점수와 어떤 차이가 있는지 확인한다. 이 변화와 연관지어 프로그램에 대한 피드백을 받고, 긍정적인 점수 변화가 있었다면 격려하며 치료동기를 강화한다. - 환자에 따라 3 회차부터 트라우마 기억 노출이 온전히 일어나는 경우가 있는데, 이런 경우 3 회차로 넘어가기보다 1~2 회차를 반복하여 충분한 노출을 꾀한다. - 3 회차에서 확인면담의 소요시간과 SUDS 가 감소하고, 환자로부터 긍정적인 이야기(e.g., ‘앞으로 내 삶이 나아질 것 같다’, ‘잘 지내보아야겠다’, ‘쓰기가 이전보다 쉽다’)가 나온다면 이후의 치료 예후가 좋다. - 다음의 확인면담을 통해 쓰기 경험에 대해 대화를 나눈다. - 구체적인 트라우마 기억에 대한 이야기는 하지 않으며, 글쓰기 경험 자체에 대하여 이야기한다. 단, 치료자가 글을 훑어본 후 인지 재구조화에 도움이 될 수 있을 것으로 판단되는 내용이 있다면 다루어보아도 좋다. - 환자의 고통이 지나치다고 판단되는 경우 우선적으로 안정화를 통해 덜 고통스러운 상태로 돌아갈 수 있도록 한다. - 환자가 고통스러운 기억을 스스로 직면할 수 있는 능력과 용기가 있다는 것을 인식하고 이에 대한 긍정적인 피드백을 준다 - 필요할 때 지원을 하고 차분함을 유지하도록 돕는다. - 외상경험을 떠올리는 것에 대한 환자의 생각과 감정을 표출할 수 있도록 한다. - 외상사건 동안 그리고 이후의 환자의 반응과 행동을 중성화하고 이를 스스로 이해할 수 있도록 돕는다. - 회기 중 혹은 회기와 회기 사이에 관찰된 습관화에 대해 말해준다. - 환자의 감정반응 중 특별히 중요하거나 의미 있다고 생각되는 부분에 대해 질문한다. - 치료가 진행되는 동안 환자의 PTSD 증상을 지속시키는 도움되지 않는 부정적 사고 또는 신념이 발견되면 확인면담 과정에서 그러한 사고와 신념을 중점에 두고 논의한다. - 개방형 질문을 사용하여 환자의 생각을 촉진시킨다. 환자가 외상을 어떻게 바라보고 어떻게 느껴야 하는지 직접적으로 말하지 않도록 한다. - 부록의 PETQ 와 같은 설문지를 활용할 수 있다. ② 마무리 - 마무리 시 다음의 멘트를 활용할 수 있다. - “매우 도전이 되는 치료였는데 아주 잘 하셨습니다. 치료 기간 동안 참 열심히 하셨습니다.”

	- “지금까지의 치료 기간이 매우 힘드셨을 텐데, 용기와 인내로 잘 극복하셨고 이제는 그 노력의 대가를 받으시는 겁니다.” - “이 치료 프로그램에서 더 많은 증상완화를 경험하지 못한 것에 대해 실망하신다고 말씀하셨지만 그러한 감정을 표현하셨던 내담자분들이 시간이 지나면서 훨씬 더 기분상태가 좋아진다는 것을 발견하게 됩니다.” - “치료과정에서 있었던 일들을 처리하고 소화시키는 데는 시간이 걸립니다. 만약 지금까지 습득한 기술들을 지속적으로 사용하신다면 시간이 지나면서 기분의 상태가 더 좋아지실 겁니다.” - “저는 이 프로그램을 완결하기 어렵다는 것을 잘 알고 있습니다. 아마 치료를 중단하고 싶으셨던 적이 여러 차례 있으셨을 거예요. 그러나 이 프로그램을 중단하지 않고 지속할 수 있는 용기를 가지셨고 바로 그것 때문에 이렇게 중요한 치료의 진전을 얻으실 수 있는 겁니다.”
--	---

PART 4. 트라우마의 영향

: 4 차 쓰기노출치료

준비물	워크북, 필기구(개별 지참)
목표	트라우마 사건이 나에게 미친 영향에 대하여 기록한다, 트라우마 관련 자극에 대한 왜곡된 인지를 수정하고 사건을 정확하게 평가한다.
회기 개요	0. 들어가며 (5 분) 1. 4 차 쓰기노출치료 (30 분) 2. 확인면담 (20 분)

0. 들어가며	① 회기와 회기 사이에 점검해야 할 것 - 다음 회기 전까지 치료자는 환자가 쓴 내용을 읽어 보면서 쓰기 지침을 잘 따랐는지, 쓰기에 잘 집중했는지, 분량은 적절한지에 대해 확인한다. 쓰기 과정에서 회피를 하면서 트라우마 사건이 발생하기 직전까지만 쓰는 등 트라우마 사건을 구체적으로 적지 못하는 경우가 있다. 이것은 제대로 된 노출이 아니기 때문에 다음 회기 때 환자에게 피드백을 주어서 본격적인 사건에 대해 써보라고 권유할 수 있다. 혹은 사건에 대한 나열만 있고 감정은 없는 경우가 있는데, 이럴 경우에는 감정에 대해 조금 더 써보라고 이야기해볼 수 있다. 환자가 과거 경험에서 느낀 감정이 아닌 지금 현재의 감정에 대해서만 서술하고 있다면 ‘지금 현재의 분노가 아니라 그때 트라우마 당시에 내가 구체적으로 무엇을 생각하고 느꼈는지에 대해 쓰는 것이다’ 식으로 재구조화해줄 필요가 있다. 치료에서의 회피 패턴이 이후로도 계속되면 WET 를 지속할 수 있을지에 대해서 고려해보아야 한다. ② 한 주간의 근황 - “안녕하세요, 한 주간 어떻게 지내셨나요? 트라우마 기억을 다루는 과정에서 힘들었던 기억이 다시 되살아나면서 어려움이 있었을 수도 있는데, 어떠셨는지 궁금합니다.” - 환자가 어려웠던 점에 대해 이야기한다면 ‘그럼에도 불구하고 이 치료를 다시 찾아주신 것이 정말 대단한 결정이라고 생각된다’ 등의 방식으로 격려와 지지를 아끼지 않는다. - 프로그램 시작 전에 현재 SUDS 를 작성하도록 한다.
1. 4 차 쓰기치료	4 차 쓰기노출치료 실시(워크북 22~23p) - 워크북에 적힌 글을 환자와 소리내어 읽으며 쓰기의 내용과 과정을 점검한다. - 쓰기노출을 위한 준비사항 - 빈 방에서 환자 혼자 글쓰기를 실시하도록 하고, 위급사항이 있을 경우 방 안의 벨을 눌러 치료자에게 알리도록 한다. - 치료자는 환자의 쓰기에 관여하지 않고 심한 해리, 공황이 올 때 안정화를 돕는 정도로는 관여할 수 있다.

	- 한 회기에서는 30 분의 글쓰기 시간이 필요하며, 글을 다 쓴 후에도 시간이 남는다면 처음부터 반복해서 다시 쓰도록 한다. - 글쓰기 종료 후에는 15~20 분 가량의 확인면담(check-in interview)을 실시한다.
2. 확인면담	① 확인면담 - 내담자의 불편감 점수를 확인한다. 프로그램을 시작할 때 내담자가 보고한 불편감 점수와 어떤 차이가 있는지 확인한다. 이 변화와 연관지어 프로그램에 대한 피드백을 받고, 긍정적인 점수 변화가 있었다면 격려하며 치료동기를 강화한다. - 이 회차까지 내담자가 쓰기 지침을 제대로 따르지 못하고 있다면, 치료의 조기 종료를 고려한다. - 다음의 확인면담을 통해 쓰기 경험에 대해 대화를 나눈다. - 구체적인 트라우마 기억에 대한 이야기는 하지 않으며, 글쓰기 경험 자체에 대하여 이야기한다. 단, 치료자가 글을 훑어본 후 인지 재구조화에 도움이 될 수 있을 것으로 판단되는 내용이 있다면 다루어보아도 좋다. - 환자의 고통이 지나치다고 판단되는 경우 우선적으로 안정화를 통해 덜 고통스러운 상태로 돌아갈 수 있도록 한다. - 환자가 고통스러운 기억을 스스로 직면할 수 있는 능력과 용기가 있다는 것을 인식하고 이에 대한 긍정적인 피드백을 준다 - 필요할 때 지원을 하고 차분함을 유지하도록 돕는다. - 외상경험을 떠올리는 것에 대한 환자의 생각과 감정을 표출할 수 있도록 한다. - 외상사건 동안 그리고 이후의 환자의 반응과 행동을 중성화하고 이를 스스로 이해할 수 있도록 돕는다. - 회기 중 혹은 회기와 회기 사이에 관찰된 습관화에 대해 말해준다. - 환자의 감정반응 중 특별히 중요하거나 의미 있다고 생각되는 부분에 대해 질문한다. - 치료가 진행되는 동안 환자의 PTSD 증상을 지속시키는 도움되지 않는 부정적 사고 또는 신념이 발견되면 확인면담 과정에서 그러한 사고와 신념을 중점에 두고 논의한다. - 개방형 질문을 사용하여 환자의 생각을 촉진시킨다. 환자가 외상을 어떻게 바라보고 어떻게 느껴야 하는지 직접적으로 말하지 않도록 한다. - 부록의 PETQ와 같은 설문지를 활용할 수 있다. ② 마무리 - 마무리 시 다음의 멘트를 활용할 수 있다. - “매우 도전이 되는 치료였는데 아주 잘 하셨습니다. 치료 기간 동안 참 열심히 하셨습니다.” - “지금까지의 치료 기간이 매우 힘드셨을 텐데, 용기와 인내로 잘 극복하셨고 이제는 그 노력의 대가를 받으시는 겁니다.” - “이 치료 프로그램에서 더 많은 증상완화를 경험하지 못한 것에 대해 실망하신다고 말씀하셨지만 그러한 감정을 표현하셨던 내담자분들이 시간이 지나면서 훨씬 더 기분상태가 좋아진다는 것을 발견하게 됩니다.”

	- “치료과정에서 있었던 일들을 처리하고 소화시키는 데는 시간이 걸립니다. 만약 지금까지 습득한 기술들을 지속적으로 사용하신다면 시간이 지나면서 기분의 상태가 더 좋아지실 겁니다.” - “저는 이 프로그램을 완결하기 어렵다는 것을 잘 알고 있습니다. 아마 치료를 중단하고 싶으셨던 적이 여러 차례 있으셨을 거예요. 그러나 이 프로그램을 중단하지 않고 지속할 수 있는 용기를 가지셨고 바로 그것 때문에 이렇게 중요한 치료의 진전을 얻으실 수 있는 겁니다.”
--	---

PART 5. 트라우마의 영향

: 5 차 쓰기노출치료

준비물	워크북, 필기구(개별 지참)
목표	트라우마 사건이 나에게 미치는 영향과 의미에 대하여 기록한다, 트라우마로부터 새로운 의미를 발견한다.
회기 개요	0. 들어가며 (5 분) 1. 5 차 쓰기노출치료 (30 분) 2. 확인면담 (20 분)

0. 들어가며	① 회기와 회기 사이에 점검해야 할 것 - 다음 회기 전까지 치료자는 환자가 쓴 내용을 읽어 보면서 쓰기 지침을 잘 따랐는지, 쓰기에 잘 집중했는지, 분량은 적절한지에 대해 확인한다. 쓰기 과정에서 회피를 하면서 트라우마 사건이 발생하기 직전까지만 쓰는 등 트라우마 사건을 구체적으로 적지 못하는 경우가 있다. 이것은 제대로 된 노출이 아니기 때문에 다음 회기 때 환자에게 피드백을 주어서 본격적인 사건에 대해 써보자고 권유할 수 있다. 혹은 사건에 대한 나열만 있고 감정은 없는 경우가 있는데, 이럴 경우에는 감정에 대해 조금 더 써보자고 이야기해볼 수 있다. 환자가 과거 경험에서 느낀 감정이 아닌 지금 현재의 감정에 대해서만 서술하고 있다면 ‘지금 현재의 분노가 아니라 그때 트라우마 당시에 내가 구체적으로 무엇을 생각하고 느꼈는지에 대해 쓰는 것이다’ 식으로 재구조화해줄 필요가 있다. 치료에서의 회피 패턴이 이후로도 계속되면 WET 를 지속할 수 있을지에 대해서 고려해보아야 한다. ② 한 주간의 근황 - “안녕하세요, 한 주간 어떻게 지내셨나요? 트라우마 기억을 다루는 과정에서 힘들었던 기억이 다시 되살아나면서 어려움이 있었을 수도 있는데, 어떠셨는지 궁금합니다.” - 환자가 어려웠던 점에 대해 이야기한다면 ‘그럼에도 불구하고 이 치료를 다시 찾아주신 것이 정말 대단한 결정이라고 생각된다’ 등의 방식으로 격려와 지지를 아끼지 않는다. - 프로그램 시작 전에 현재 SUDS 를 작성하도록 한다.
1. 5 차 쓰기치료	5 차 쓰기노출치료 실시(워크북 26~27p) - 워크북에 적힌 글을 환자와 소리내어 읽으며 쓰기의 내용과 과정을 점검한다. - 쓰기노출을 위한 준비사항 - 빈 방에서 환자 혼자 글쓰기를 실시하도록 하고, 위급사항이 있을 경우 방 안의 벨을 눌러 치료자에게 알리도록 한다. - 치료자는 환자의 쓰기에 관여하지 않고 심한 해리, 공황이 올 때 안정화를 돕는 정도로는 관여할 수 있다.

	- 한 회기에서는 30 분의 글쓰기 시간이 필요하며, 글을 다 쓴 후에도 시간이 남는다면 처음부터 반복해서 다시 쓰도록 한다. - 글쓰기 종료 후에는 15~20 분 가량의 확인면담(check-in interview)을 실시한다.
2. 확인면담	① 확인면담 - 내담자의 불편감 점수를 확인한다. 프로그램을 시작할 때 내담자가 보고한 불편감 점수와 어떤 차이가 있는지 확인한다. 이 변화와 연관지어 프로그램에 대한 피드백을 받고, 긍정적인 점수 변화가 있었다면 격려하며 치료동기를 강화한다. - 더 이상 쓰기에 대한 피드백을 제공하지 않고 긍정적인 피드백으로 마무리한다. - 5 번의 쓰기를 했다고 드라마틱하게 좋아지는 것이 아니고, 트라우마 경험에 대처하는 방법을 배운 것이며 이제부터가 진짜 호전의 시작이라고 격려한다. - 치료 종료 후 스트레스(부정적 스트레스뿐 아니라 긍정적 스트레스를 포함한다는 점을 강조한다) 상황에서 증상이 일시적으로 증가될 가능성이 있음을 알리고 이에 대해 논의한다. ② 마무리 - 그동안 작성한 SUDS 와 HADS 를 정리하여 그래프로 그려 본다. 프로그램 전후로 차이가 있을 경우 이를 반가워하며 축하하는 시간을 가지고, 큰 변화가 없을 경우 트라우마 기억을 다루는 과정이 진행되고 있음에 대해 이야기하며 차차 변화가 생길 것을 기대해보도록 격려한다. - 마무리 시 다음의 멘트를 활용할 수 있다. - “매우 도전이 되는 치료였는데 아주 잘 하셨습니다. 치료 기간 동안 참 열심히 하셨습니다.” - “지금까지의 치료 기간이 매우 힘드셨을 텐데, 용기와 인내로 잘 극복하셨고 이제는 그 노력의 대가를 받으시는 겁니다.” - “이 치료 프로그램에서 더 많은 증상완화를 경험하지 못한 것에 대해 실망하신다고 말씀하셨지만 그러한 감정을 표현하셨던 내담자분들이 시간이 지나면서 훨씬 더 기분상태가 좋아진다는 것을 발견하게 됩니다.” - “치료과정에서 있었던 일들을 처리하고 소화시키는 데는 시간이 걸립니다. 만약 지금까지 습득한 기술들을 지속적으로 사용하신다면 시간이 지나면서 기분의 상태가 더 좋아지실 겁니다.” - “저는 이 프로그램을 완결하기 어렵다는 것을 잘 알고 있습니다. 아마 치료를 중단하고 싶으셨던 적이 여러 차례 있으셨을 거예요. 그러나 이 프로그램을 중단하지 않고 지속할 수 있는 용기를 가지셨고 바로 그것 때문에 이렇게 중요한 치료의 진전을 얻으실 수 있는 겁니다.”

[부록 1] PETQ(PE therapy questionnaire)를 활용한 확인면담 질문 예시

	PETQ 질문	확인면담 질문 예시
관여하기	얼마나 쓰기 활동에 적극적으로 관여하였는가?	오늘 쓰기는 어땠나요?, 예상했던 것보다 더 어려움이 있었나요?, 지난 시간에 비해 힘들었나요?, 지난 회기와 이번 회기 사이에 어떤 차이가 있었나요?
	쓰기 과정에서 얼마나 기억을 구체화하였는가?	오늘 쓰기 과정에서 얼마나 구체적으로 사건에 대해 쓸 수 있었던 것 같나요?, 사건의 구체적 내용/당시의 감정 등 구체적으로 작성하기 어려웠던 부분이 있었나요?
	이전까지는 잊고 있었거나 관심을 두지 않았던 기억의 새로운 측면을 상기해냈는가?	혹시 그 전까지는 몰랐는데 이번 쓰기 활동을 통해 새롭게 떠올리거나 깨달은 것이 있었나요?
처리하기	트라우마의 새로운 의미를 발견하였는가?	이렇게 힘든 사건이었지만, 그럼에도 이 사건의 긍정적인 부분에 대해 이야기할 수 있는 부분들이 있을까요?, 당시 당신의 행동에 대해서 지금은 어떤 생각을 가지고 계신가요?, 트라우마 사건에 대하여 관점이 달라진 부분이 있나요?, 이런 일이 벌어진 것이 당신에게 어떤 의미가 있나요?, 이런 방식으로 생각할 때 어떤 느낌이 드셨나요?, 이 트라우마 사건이 당신에 관해 무엇을 말해 주나요?
	새롭게 기억된 부분을 통해 트라우마의 새로운 의미를 발견하였는가?	아까 말씀하신 새로운 기억이 트라우마에 대한 관점을 변화시킨 부분이 있을까요?
	자신에 대한 새로운 이해를 형성하였는가?	트라우마 경험과 관련하여 나에 대해 다르게 생각된 부분이 있나요?, 트라우마 경험은 당신에 관해서 무엇을 말해 주나요?, 이런 방식으로 나 자신에 대해 생각하는 것이 어떤 느낌을 주나요?
	타인에 대한 새로운 이해를 형성하였는가?	트라우마 경험과 관련하여 다른 사람들에 대해 다르게 생각된 부분이 있나요?
	세상에 대한 새로운 이해를 형성하였는가?	트라우마 경험과 관련하여 내가 세상을 보는 관점에 대해 다르게 생각된 부분이 있나요?

[부록 2] PETQ 원본

1. 쓰기 활동에 얼마나 참여했는가(*engagement*):

0	1	2	3	4	5
전혀 관여하지 못했다	아주 약간 관여했다	약간 관여했다	보통 수준이다	많이 관여했다	매우 많이 관여했다

2. 트라우마 기억에 대한 구체화(*elaboration* of trauma memory):

0	1	2	3	4	5
전혀 구체화 하지 못했다	아주 약간 구체화했다	약간 구체화했다	보통 수준이다	많이 구체화했다	매우 많이 구체화했다

3. 환자는 이전까지는 잊고 있었거나 관심을 두지 않았던 기억의 새로운 측면을 상기해냈다(Patient *remembered* aspect of memory previously forgotten or unattended to)

0—아니다 1—소수 기억에 대하여 그렇다 2—중요한 기억에 대하여 그렇다

처리하기(*processing*)

4. 환자는 트라우마의 새로운 의미를 발견했다(Patient developed *new meaning* of the trauma):

0	1	2	3	4	5
전혀 발견하지 못했다	아주 약간 발견했다	약간 발견했다	보통 수준이다	많이 발견했다	매우 많이 발견했다

5. 환자는 새롭게 기억된 부분을 통해 트라우마의 새로운 의미를 발견하였다(Patient developed new meaning of trauma *based on newly remembered* aspect of memory):

0	1	2	3	4	5
전혀 발견하지 못했다	아주 약간 발견했다	약간 발견했다	보통 수준이다	많이 발견했다	매우 많이 발견했다

6. 환자는 자신에 대한 새로운 이해를 형성하였다(Patient developed new understanding of *self*):

0	1	2	3	4	5
전혀 형성하지 못했다	아주 약간 형성했다	약간 형성했다	보통 수준이다	많이 형성했다	매우 많이 형성했다

7. 환자는 세상에 대한 새로운 이해를 형성하였다(Patient developed new understanding of *world*):

0	1	2	3	4	5
전혀 형성하지 못했다	아주 약간 형성했다	약간 형성했다	보통 수준이다	많이 형성했다	매우 많이 형성했다

8. 환자는 트라우마 기억에 대하여 더 많은 통제감을 획득했다고 보고하였다(Patient stated she/he has greater *mastery/control* over trauma memory):

0	1	2	3	4	5
전혀 그렇지 않다	아주 약간 그렇다	약간 그렇다	보통 수준이다	많이 그렇다	매우 많이 그렇다

참고문헌

- Abramowitz, J. S., Deacon, B. J., & Whiteside, S. P. H. (2019). *Exposure Therapy for Anxiety* (2nd ed.). Guilford Press. (김선욱 외 역, 《노출치료의 혁신: 억제학습이론을 기반으로》, 삶과지식, 2021)
- Calhoun, L. G., & Tedeschi, R. G. (2012). *Posttraumatic growth in clinical practice*. Routledge.
- Cox, K. S., Wangelin, B. C., Keller, S. M., Lozano, B. E., Murphy, M. M., Maher, E. K., ... & Tuerk, P. W. (2020). Emotional processing of imaginal exposures predicts symptom improvement: Therapist ratings can assess trajectory in prolonged exposure for posttraumatic stress disorder. *Journal of Traumatic Stress, 33*(3), 338-344.
- Sloan, D. M., Lee, D. J., Litwack, S. D., Sawyer, A. T., & Marx, B. P. (2013). Written exposure therapy for veterans diagnosed with PTSD: A pilot study. *Journal of Traumatic Stress, 26*(6), 776-779. <https://doi.org/10.1002/jts.21858>
- 송승훈, 김교현, 이홍석, 박준호 (2009) 한국판 외상후 성장 척도의 타당도 및 신뢰도 연구. *한국심리학회지: 건강, 14*(1), 193-214.
- 신선영, 정남운 (2012) 삶의 의미와 사회적 지지가 외상 후 성장에 미치는 영향: 성장적 반추를 매개 변인으로. *인간이해, 33*(2), 217-235.